

Cover sheet / Deckblatt

Case number / Fallnummer: DE-BFARM-07084659 (1386599)

Case type / Falltyp: SLAVE



HELIOS Klinikum Wuppertal

Universitätsklinikum der Universität Witten/Herdecke

HELIOS Klinikum Wuppertal
Heusnerstr. 40 • D-42283 Wuppertal

Dr. Horst Hillen
Bundesinstitut für Arzneimittel
und Medizinprodukte
Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3
D-53175 Bonn

Philipp Klee-Institut für
Klinische Pharmakologie
Direktorin
Prof. Dr. med. Petra A.
Thürmann

Ansprechpartner

Zeichen Th/ab

Tel. 0202 / 896-1850
Fax 0202 / 896-1852

E-Mail
pthuermann@
helios-kliniken.de

Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte	
09. Aug. 2007	72.12 P.
Anz.: 3832	1709 J
Nr.: 184282/07	ig

08. August 2007

73 ~~0000~~
14.8.07

=> 71 xl

20.17.

Projekt: "Erfassung und Bewertung von unerwünschten Arzneimittelwirkungen die zum Krankenhausaufenthalt führen" (Projektleitung: Prof. Dr. Joerg Hasford, IBE)

Sehr geehrter Herr Dr. Hillen,

anbei erhalten Sie die UAW-Meldungen aus dem Jahre 2006 auf CD.

Für Ihre Rückmeldung (Kommentare, Wünsche, Anregungen) wäre ich sehr dankbar,

Mit freundlichen Grüßen,

Jacek Szymanski
Assistenzarzt

07084 268
07084 272
07084 284
07084 293
07084 584
07084 640
07084 647
07084 659
07084 815
07085 033

07084659

1. Wurde die UAW durch ein Medikament verursacht, dessen Einnahme unnötig war (fehlende Indikation)?

Nein

2. Wurde die UAW durch Medikamenteneinnahme zu einem Zeitpunkt verursacht, als die Einnahme bereits nicht mehr nötig war (Medikament nicht rechtzeitig abgesetzt)?

Nein

3. War das Medikament/die Medikamente, das/die die UAW verursacht hat/haben nicht an Alter, Gewicht, Organfunktion sowie Art und Schwere der (Begleit)erkrankungen des Patienten angepaßt?

Nein

4. War das/die verdächtige/n Medikament/e eindeutig ungeeignet oder kontraindiziert (z.B. entsprechender Hinweis in der Fachinformation)?

Nein

5. Waren Dosierung, Applikationsweg, Häufigkeit der Applikation des/ der verdächtigten Medikament/e eindeutig ungeeignet für Alter, Gewicht sowie Art und Schwere der (Begleit)erkrankungen der Patientin/ des Patienten?

Nein

6. Wurde eine notwendige Dosisanpassung renal eliminerter Substanzen bei Patienten mit eingeschränkter Nierenfunktion nicht durchgeführt?

Nein

7. Wurden notwendige und geeignete Kontrolluntersuchungen (z.B. Laborbefunde, körperliche Untersuchung, EKG) nicht durchgeführt bzw. deren Ergebnisse nicht zur Kenntnis genommen?

Nein

8. Hatte der Patient eine bekannte Allergie bzw. bereits früher eine UAW auf das gleiche Medikament/ ein Medikament aus der gleichen Arzneimittelklasse?

Nein

9. War eine bekannte und in der Fachinformation aufgeführte Medikamenteninteraktion an der UAW beteiligt?

Ja

10. Wurde das/die verdächtige/n Medikament/e anders als vom Arzt verordnet angewendet?

Nein

10a. Wenn ja, wie?

11. Wurde die UAW durch ein Medikament/ mehrere Medikamente verursacht, das/ die nicht aktuell vom Arzt verordnet worden ist/ sind (z.B. Selbstmedikation)?

Ja

12. Wurden notwendige und allgemein akzeptierte Präventionsmaßnahmen (z.B. Ulkusprophylaxe bei Gabe von NSAIDs bei Patienten mit bekannter Ulkusanamnese) nicht durchgeführt?

Nein

13. Kommentare zur Vermeidbarkeit: Nicht vermeidbar

14. Wurden in den letzten vier Wochen neue Medikamente eingenommen?

Ja

15. Fand in den letzten vier Wochen ein Arztbesuch statt?

Ja

Dienstag, 7. August 2007		Bearb.ende :		Platfile:	
Seite 2533 von 2813					

7-1616

☐ Bevorzugt

Studienregion

7

Abschlußbericht ☒ 03.08.2007

Beg. 07.08.2006	Ende: 30.08.2006	UAW-Beschreibung	UAW-Ther.	UAW-Verlauf	Ausgang:
Stat. ☐	Typ A	Am Morgen Schwarz vor Augen, kein Schwindel, keine Übelkeit, kein Erbrechen. Vom Notarzt Blutzucker 1,9 mmol/l gemessen, unter Glucosegabe Besserung der Vigilanz, keine antidiabetische Therapie. Am 01.08.06 erst entlassen, seit dem allgemeine Schwäche + Druckgefühl im Epigastrium + Appetitlosigkeit. Dort (nierenärztliche Klinik) behandelt wegen Gelenkschmerzen L.R. Angina tonsillaris, wegen Legionelleninfekt mit Tavanic behandelt. Volleran wegen Schmerzen der Gelenke.	Notarzt: 12 g Glucose + 500 ml Glucose 5 % 07.08.06: Tavanic + Voltaren abgesetzt; Pantozol Kurzinfusion 1xgl., 1000 ml Sterolundin i.v. Im Rahmen der Krampfanfälle Jeweils Diazepam i.v. Jena: Hämodialyse; zwischenzeitlich Einstellung auf Phenytoin nach erneutem Krampfanfall Tazobac bei fehlten Temperaturen, Lactulose seit 22.08.05 Prednisonersatztherapie	- Oberbauchsonographie: Leber vergrößert, inhomogen, Leberarterien stark schlecht darstellbar, Venen zart, Gallenblase mit verdickter Wand und Stude, kein Nachweis von Aszites. Pankreas und Aorta soweit bei Luftüberlagerung darstellbar unauffällig. Nieren im Längsdurchmesser bds. 11 cm, keine Harnstauung, Milzgröße im Normbereich. - 08.08.06 CCT: Unauf. cerebrales CT, insbesondere kein Nachweis einer Intraazerebralen Blutung - 08.08.06: 3 x cerebrale Krampfanfälle, Verlegung nach Jena. Dort bis 12.08.05 auf Intensivstation mit Durchführung Hämodialyse und nach erneutem Krampfanfall zwischenzeitlich Gabe von Phenytoin. - Antibiose mit Tazobac bei fehlten Temperaturen, seit 22.08.05 Prednisonersatztherapie, darunter vollständig - Kein Hinweis auf Morbus Wilson, Hämochromatose, Autoimmunerkrankung oder infektiöse Hepatitis, - Niere: schwere interstitielle Nephritis.	Noch nicht wiederhergestellt Schwerw. ☒ Grad Level 5 Art des Probl. UAW und Interaktion HP-Befall Nicht untersucht/Unbekannt

Erläuterungen zur
Kaus.beurteilung:

Die stationäre Aufnahme erfolgte wegen Hypoglykämie und epigastrischen Schmerzen i.S. einer Gastritis. Unschätzlich für die Hypoglykämie ist wahrscheinlich das akute Leberversagen mit massiv erhöhten Transaminasen, Bilirubin und vermindertem Sponan-Quickwert. Für das Organversagen (Leber- und Niere) kommt vor allem eine medikamentös-toxische Genese unter Einnahme von Tavanic bei Argina-tonsillitis und Legionellose in Betracht. Differentialdiagnostisch muß jedoch auch an einer Immunreaktion nach Streptokokkeninfekt gedacht werden.
Der Entlassungsbericht der FSU Jena enthält den Verdacht auf eine medikamentös-toxische Genese. Anamnestisch wurde von den Kollegen eine zusätzliche Lorazepam-Einnahme eruiert, die Länge der Einnahme ist jedoch nicht ganz klar.

Anamdatum: 07.08.2006	Appl.-Haut: ☐	1	x	Days	von - bis	29.07.2006	weiterhin	Bei Aufnahme Ja
MedName: Berthylpro	Appl.Dosis: 25	Dos.einheit: Mg	Intakation:	V.a. Autoimmunthyreoiditis Hashimoto;	Ch.-Nr	Selbstmed.: Ja		
Bar.form: Tabletten	Appl.form: Oral			Hypothyreose	Maßnahmen:	Keine Änderung		
Kausalitätsbeurteilung:	Begaud-Score (Chron./Sympt./Impulab./Bibl.):				früher gegeben?	Nein	vertragen	Nein
UAW: HYPOTHYREOMIE					Bei Reax:			
Zusammenhang zur UAW vermutet?					UAW erneut			
					aufgetreten?			
Kausalitätsbeurteilung:	Begaud-Score (Chron./Sympt./Impulab./Bibl.):							
UAW: LEBERVERSAGEN								
Zusammenhang zur UAW vermutet?								
Kausalitätsbeurteilung:	Begaud-Score (Chron./Sympt./Impulab./Bibl.):							
UAW: NIERENVERSAGEN AKUT								
Zusammenhang zur UAW vermutet?								

Dienstag, 7. August 2007

Bearb.beg/fin:

Bearb.ende :

Faltfile:

Seite 2531 von 2873

07084659

7-1616 ☐ Bevorzugt Studienregion 7Abschlußbericht ☒ 03.08.2007

Anamdatum: MedName: Darform:	07082006 Lorano Tabletten	1 10 Oral	x As Necessary Doseinheit: Mg	von - bis Indikation:	unbekannt Rhinitis	07082006	Bei Aufnahme Ch-Nr Medikament Rolle d. Med.	Ja Selbstmed.: Ja Medikament abgesetzt Interagierend
Kausalitätsbeurteilung:	Begaud-Score (Chron./Sympl./Impulab./Bibl.):	Klin.-pharmakol. Beurteilg.:		früher gegeben?	Nein	vertragen	Nein	Lorazepam bei eingeschränkter Leber- u. Nierenfkt. ZNS-Wirkungen wie Somnolenz erhöht, < 1/10000 Leberfunktionsstörungen
UAW:	HYPOGLYKÄEMIE	[2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100]	Klin.-pharmakol. Beurteilg.:	Bei Reex: UAW erneut aufgetreten?	Nein	vertragen	Nein	
Zusammenhang zur UAW vermutet?	☒	In Fachinfo dokumentiert?	Bereits dokumentiert					
Kausalitätsbeurteilung:	Begaud-Score (Chron./Sympl./Impulab./Bibl.):	Klin.-pharmakol. Beurteilg.:		früher gegeben?	Nein	vertragen	Nein	
UAW:	LEBERVERSAGEN	[2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100]	Klin.-pharmakol. Beurteilg.:	Bei Reex: UAW erneut aufgetreten?	Nein	vertragen	Nein	
Zusammenhang zur UAW vermutet?	☒	In Fachinfo dokumentiert?	Bereits dokumentiert					
Kausalitätsbeurteilung:	Begaud-Score (Chron./Sympl./Impulab./Bibl.):	Klin.-pharmakol. Beurteilg.:		früher gegeben?	Nein	vertragen	Nein	
UAW:	NIERENVERSAGEN AKUT	[2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100]	Klin.-pharmakol. Beurteilg.:	Bei Reex: UAW erneut aufgetreten?	Nein	vertragen	Nein	
Zusammenhang zur UAW vermutet?	☐	In Fachinfo dokumentiert?	Nicht beurteilt/Unbekannt					
Anamdatum: MedName: Darform:	07082006 paritazol Tabletten	1 10 Oral	x As Necessary Doseinheit: Mg	von - bis Indikation:	29072006 Magenschutz	07082006	Bei Aufnahme Ch-Nr Medikament Rolle d. Med.	Ja Selbstmed.: Nein Keine Änderung Interagierend
Kausalitätsbeurteilung:	Begaud-Score (Chron./Sympl./Impulab./Bibl.):	Klin.-pharmakol. Beurteilg.:		früher gegeben?	Nein	vertragen	Nein	
UAW:	HYPOGLYKÄEMIE	[2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100]	Klin.-pharmakol. Beurteilg.:	Bei Reex: UAW erneut aufgetreten?	Nein	vertragen	Nein	
Zusammenhang zur UAW vermutet?	☒	In Fachinfo dokumentiert?	Bereits dokumentiert					
Kausalitätsbeurteilung:	Begaud-Score (Chron./Sympl./Impulab./Bibl.):	Klin.-pharmakol. Beurteilg.:		früher gegeben?	Nein	vertragen	Nein	
UAW:	LEBERVERSAGEN	[2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100]	Klin.-pharmakol. Beurteilg.:	Bei Reex: UAW erneut aufgetreten?	Nein	vertragen	Nein	
Zusammenhang zur UAW vermutet?	☒	In Fachinfo dokumentiert?	Bereits dokumentiert					
Kausalitätsbeurteilung:	Begaud-Score (Chron./Sympl./Impulab./Bibl.):	Klin.-pharmakol. Beurteilg.:		früher gegeben?	Nein	vertragen	Nein	
UAW:	NIERENVERSAGEN AKUT	[2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100]	Klin.-pharmakol. Beurteilg.:	Bei Reex: UAW erneut aufgetreten?	Nein	vertragen	Nein	
Zusammenhang zur UAW vermutet?	☐	In Fachinfo dokumentiert?	Nicht beurteilt/Unbekannt					
Anamdatum: MedName: Darform:	07082006 Levanic Filmtabletten	1 500 Oral	x As Necessary Doseinheit: Mg	von - bis Indikation:	29072006 Angina tonsillaris, Legionellose	07082006	Bei Aufnahme Ch-Nr Medikament Rolle d. Med.	Ja Selbstmed.: Nein Medikament abgesetzt verdrängend
Kausalitätsbeurteilung:	Begaud-Score (Chron./Sympl./Impulab./Bibl.):	Klin.-pharmakol. Beurteilg.:		früher gegeben?	Nein	vertragen	Nein	< 0,1 % Hypoglykämien, 1-10 % Leberenzym erhöht, 0,1-0,01% Bill. erhöht, Krea erhöht, < 0,01% Hepatitis, akutes Nierenversagen
UAW:	HYPOGLYKÄEMIE	[2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100]	Klin.-pharmakol. Beurteilg.:	Bei Reex: UAW erneut aufgetreten?	Nein	vertragen	Nein	
Zusammenhang zur UAW vermutet?	☒	In Fachinfo dokumentiert?	Bereits dokumentiert					
Kausalitätsbeurteilung:	Begaud-Score (Chron./Sympl./Impulab./Bibl.):	Klin.-pharmakol. Beurteilg.:		früher gegeben?	Nein	vertragen	Nein	
UAW:	LEBERVERSAGEN	[2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100]	Klin.-pharmakol. Beurteilg.:	Bei Reex: UAW erneut aufgetreten?	Nein	vertragen	Nein	
Zusammenhang zur UAW vermutet?	☒	In Fachinfo dokumentiert?	Bereits dokumentiert					
Kausalitätsbeurteilung:	Begaud-Score (Chron./Sympl./Impulab./Bibl.):	Klin.-pharmakol. Beurteilg.:		früher gegeben?	Nein	vertragen	Nein	
UAW:	NIERENVERSAGEN AKUT	[2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100]	Klin.-pharmakol. Beurteilg.:	Bei Reex: UAW erneut aufgetreten?	Nein	vertragen	Nein	
Zusammenhang zur UAW vermutet?	☒	In Fachinfo dokumentiert?	Bereits dokumentiert					